# OBJECTIF CERTIF'




## Certification HAS : M-1

## Sommes-nous prêts ?

*G. SILVETTI - IDE Référent, service des urgences.*

# OBJECTIF CERTIF’

La certification ne consiste pas à **réciter le référentiel HAS**.

Les experts-visiteurs vont chercher à comprendre et observer **nos pratiques réelles**, notamment à travers les cinq méthodes d’évaluation (Newsletter n°13).



**Il faut savoir expliquer ce que l’on fait… et pourquoi on le fait.**

Un expert-visiteur peut vous poser des questions sur **votre pratique quotidienne**.

- *« Comment vérifiez-vous l’identité du patient ? »*
- *« Que faites-vous après l’administration d’un antalgique ? »*
- *« Comment déclarez-vous un événement indésirable ? »*
- *« Que faites-vous face à une urgence vitale ? »*

## La bonne réponse ?

**Expliquez simplement ce que VOUS faites au quotidien.**

*Il ne s’agit pas de chercher **« la réponse HAS »**, mais de montrer que nos pratiques sont **connues, maîtrisées et sécurisées**.*

# OBJECTIF CERTIF’

Gardons 3 mots en tête

## CE QUE JE DIS

Je sais expliquer ma pratique et pourquoi je la réalise.

## CE QUE JE FAIS

Mes pratiques quotidiennes correspondent à ce que j’explique.

## CE QUE JE TRACE

Le dossier et les outils de traçabilité permettent de retrouver ce qui a été réalisé.
Le patient traceur illustre particulièrement cette logique : l’expert interroge le patient, échange avec l'équipe puis vérifie la traçabilité dans le dossier.



# OBJECTIF CERTIF’ 🏆

Et surtout… 👀

**La certification ne commence pas lorsque l’expert nous pose une question.**

Elle commence dès qu’il entre dans le service.

Tenue professionnelle • Hygiène des mains • Confidentialité • Intimité du patient • Identitovigilance • Médicaments à risque • Accessibilité du chariot d’urgence…

Les pratiques sont observées tout au long de la visite.

**Chaque détail compte.**

# OBJECTIF CERTIF'







*Newsletter n°1 - Certification des établissements de santé : êtes vous prêts ?*

## TAKE HOME MESSAGES

**La certification, c'est l'évaluation de NOS pratiques au quotidien.**

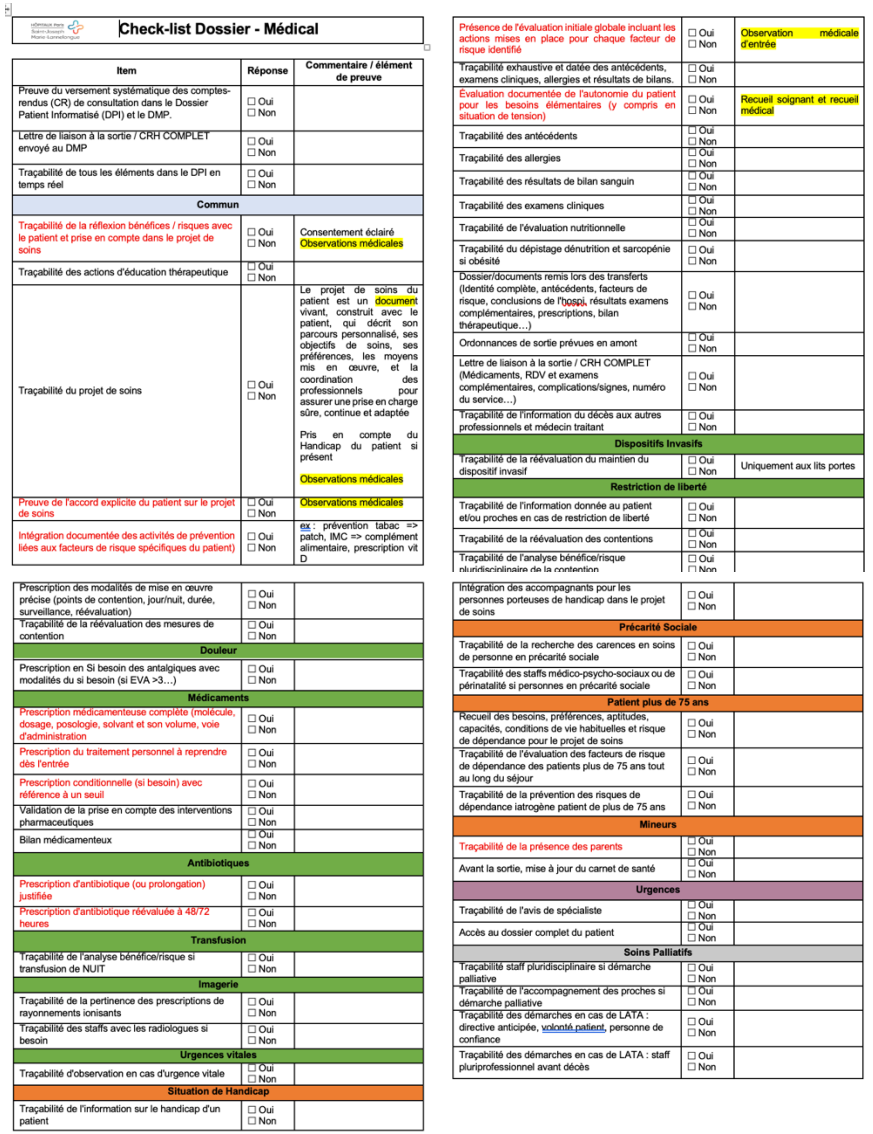
→ Les experts-visiteurs viennent sur le terrain : **ce que je fais, ce que je sais expliquer et ce que je trace.**

**Critère impératif = exigence NON NÉGOCIABLE.**

→ Ce sont les points sur lesquels **nous devons tous être au rendez-vous.**

**Pas besoin de "réciter" la certification : il faut montrer nos bonnes pratiques.**

→ Patient traceur, parcours traceur, traceur ciblé, audit système et observations : **le terrain est au cœur de l'évaluation.**



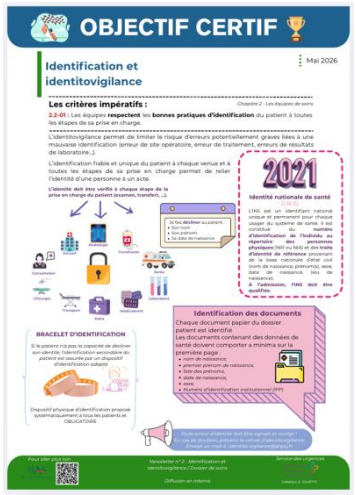
**Check-list Dossier - Médical**

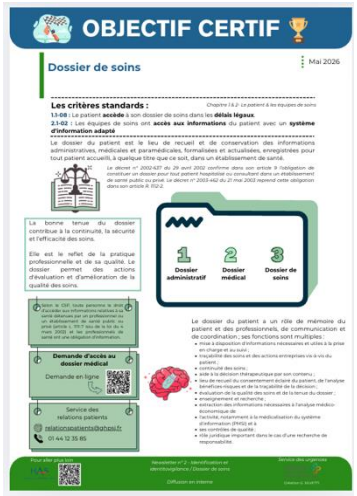
| Item | Réponse | Commentaire / élément de preuve |
|---|---|---|
| Preuve du versement systématique des comptes-rendus (CR) de consultation dans le Dossier Patient Informatisé (DPI) et le DMP. | ☐ Oui ☐ Non | |
| Lettre de liaison à la sortie / CRH COMPLET envoyé au DMP | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de tous les éléments dans le DPI en temps réel | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Commun** | | |
| Traçabilité de la réflexion bénéfices / risques avec le patient et prise en compte dans le projet de soins | ☐ Oui ☐ Non | Consentement éclairé Observations médicales |
| Traçabilité des actions d'éducation thérapeutique | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité du projet de soins | ☐ Oui ☐ Non | Le projet de soins du patient est un document vivant, construit avec le patient, qui décrit son parcours personnalisé, ses objectifs de soins, ses préférences, les moyens mis en œuvre, et la coordination des professionnels pour assurer une prise en charge sûre, continue et adaptée<br>Pris en compte du Handicap du patient si présent<br>Observations médicales |
| Preuve de l'accord explicite du patient sur le projet de soins | ☐ Oui ☐ Non | Observations médicales |
| Intégration documentée des activités de prévention liées aux facteurs de risque spécifiques du patient) | ☐ Oui ☐ Non | ex : prévention tabac => patch, IMC => complément alimentaire, prescription vit D |
| Prescription des modalités de mise en œuvre précise (points de contention, jour/nuit, durée, surveillance, réévaluation) | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de la réévaluation des mesures de contention | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Douleur** | | |
| Prescription en Si besoin des antalgiques avec modalités du si besoin (si EVA >3…) | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Médicaments** | | |
| Prescription médicamenteuse complète (molécule, dosage, posologie, solvant et son volume, voie d'administration | ☐ Oui ☐ Non | |
| Prescription du traitement personnel à reprendre dès l'entrée | ☐ Oui ☐ Non | |
| Prescription conditionnelle (si besoin) avec référence à un seuil | ☐ Oui ☐ Non | |
| Validation de la prise en compte des interventions pharmaceutiques | ☐ Oui ☐ Non | |
| Bilan médicamenteux | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Antibiotiques** | | |
| Prescription d'antibiotique (ou prolongation) justifiée | ☐ Oui ☐ Non | |
| Prescription d'antibiotique réévaluée à 48/72 heures | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Transfusion** | | |
| Traçabilité de l'analyse bénéfice/risque si transfusion de NUIT | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Imagerie** | | |
| Traçabilité de la pertinence des prescriptions de rayonnements ionisants | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des staffs avec les radiologues si besoin | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Urgences vitales** | | |
| Traçabilité d'observation en cas d'urgence vitale | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Situation de Handicap** | | |
| Traçabilité de l'information sur le handicap d'un patient | ☐ Oui ☐ Non | |
| Présence de l'évaluation initiale globale incluant les actions mises en place pour chaque facteur de risque identifié | ☐ Oui ☐ Non | Observation médicale d'entrée |
| Traçabilité exhaustive et datée des antécédents, examens cliniques, allergies et résultats de bilans. | ☐ Oui ☐ Non | |
| Évaluation documentée de l'autonomie du patient pour les besoins élémentaires (y compris en situation de tension) | ☐ Oui ☐ Non | Recueil soignant et recueil médical |
| Traçabilité des antécédents | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des allergies | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des résultats de bilan sanguin | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des examens cliniques | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de l'évaluation nutritionnelle | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité du dépistage dénutrition et sarcopénie si obésité | ☐ Oui ☐ Non | |
| Dossier/documents remis lors des transferts (Identité complète, antécédents, facteurs de risque, conclusions de l'hospi, résultats examens complémentaires, prescriptions, bilan thérapeutique…) | ☐ Oui ☐ Non | |
| Ordonnances de sortie prévues en amont | ☐ Oui ☐ Non | |
| Lettre de liaison à la sortie / CRH COMPLET (Médicaments, RDV et examens complémentaires, complications/signes, numéro du service…) | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de l'information du décès aux autres professionnels et médecin traitant | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Dispositifs Invasifs** | | |
| Traçabilité de la réévaluation du maintien du dispositif invasif | ☐ Oui ☐ Non | Uniquement aux lits portes |
| **Restriction de liberté** | | |
| Traçabilité de l'information donnée au patient et/ou proches en cas de restriction de liberté | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de la réévaluation des contentions | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de l'analyse bénéfice/risque pluridisciplinaire de la contention | ☐ Oui ☐ Non | |
| Intégration des accompagnants pour les personnes porteuses de handicap dans le projet de soins | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Précarité Sociale** | | |
| Traçabilité de la recherche des carences en soins de personne en précarité sociale | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des staffs médico-psycho-sociaux ou de périnatalité si personnes en précarité sociale | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Patient plus de 75 ans** | | |
| Recueil des besoins, préférences, aptitudes, capacités, conditions de vie habituelles et risque de dépendance pour le projet de soins | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de l'évaluation des facteurs de risque de dépendance des patients plus de 75 ans tout au long du séjour | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de la prévention des risques de dépendance iatrogène patient de plus de 75 ans | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Mineurs** | | |
| Traçabilité de la présence des parents | ☐ Oui ☐ Non | |
| Avant la sortie, mise à jour du carnet de santé | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Urgences** | | |
| Traçabilité de l'avis de spécialiste | ☐ Oui ☐ Non | |
| Accès au dossier complet du patient | ☐ Oui ☐ Non | |
| **Soins Palliatifs** | | |
| Traçabilité staff pluridisciplinaire si démarche palliative | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité de l'accompagnement des proches si démarche palliative | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des démarches en cas de LATA : directive anticipée, volonté patient, personne de confiance | ☐ Oui ☐ Non | |
| Traçabilité des démarches en cas de LATA : staff pluriprofessionnel avant décès | ☐ Oui ☐ Non | |


HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

*G. SILVETTI - IDE Référent, service des urgences.*

# OBJECTIF CERTIF’




*Newsletter n° 2 - Identification et identitovigilance / Dossier de soins*

## TAKE HOME MESSAGES

**À CHAQUE étape = je vérifie l’identité !**



→ Je fais décliner au patient : **NOM • PRÉNOM • DATE DE NAISSANCE.**
Je ne me contente jamais du numéro de chambre ou de connaître le patient.

**Une erreur d’identité ? Je la signale et je la fais corriger !**

→ En cas de doublon → **cellule d’identitovigilance.**

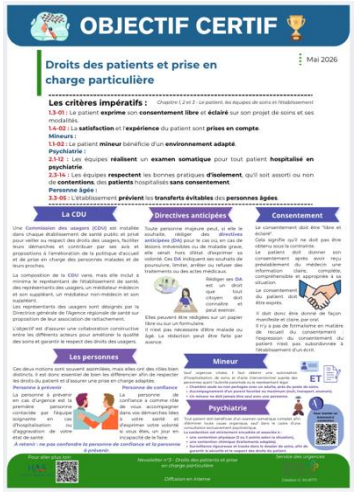
**Pas fait ? Pas tracé ? = Impossible à prouver.**

→ Le dossier assure la **traçabilité et la continuité des soins** : les informations doivent être **formalisées et actualisées.**

# OBJECTIF CERTIF’

## TAKE HOME MESSAGES




*Newsletter n°3 - Droits des patients et prise en charge particulière*

🤝 **Pas de soin sans information et consentement.**

→ Le patient reçoit une information **claire, compréhensible et adaptée**, puis exprime un consentement **libre et éclairé**.

👥 **Personne de confiance ≠ personne à prévenir !**

→ **Personne de confiance** : accompagne le patient et peut exprimer sa volonté s’il ne peut plus le faire.
→ **Personne à prévenir** : personne contactée en cas de besoin.

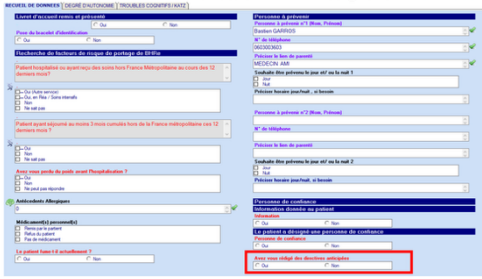
🔒 **Isolement / contention = mesure encadrée, surveillée et TRACÉE.**

→ La **surveillance** doit être **rigoureuse et tracée dans le dossier de soins**, pour garantir sécurité et respect des droits du patient. La lever de contention doit être noter dans le dossier de soins




## Directives anticipées

Intégration d’une question dans le **recueil d’entrée soignant** : *Avez-vous rédiger vos directives ?* Oui / Non



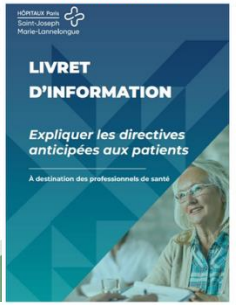
→ Formulaire à numériser dans les documents externes Dxcare dans le type *« directives anticipées »*




Patients

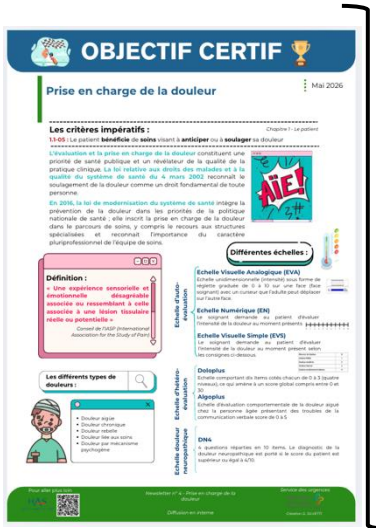


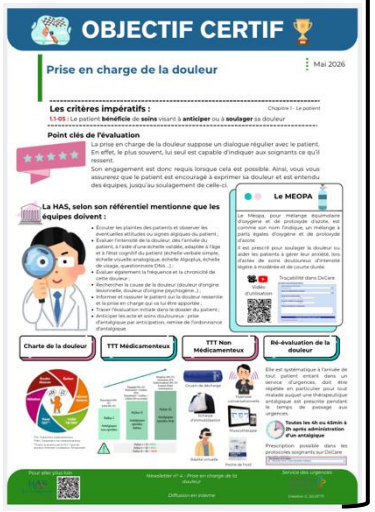

Professionnels




*G. SILVETTI - IDE Référent, service des urgences.*

# OBJECTIF CERTIF’



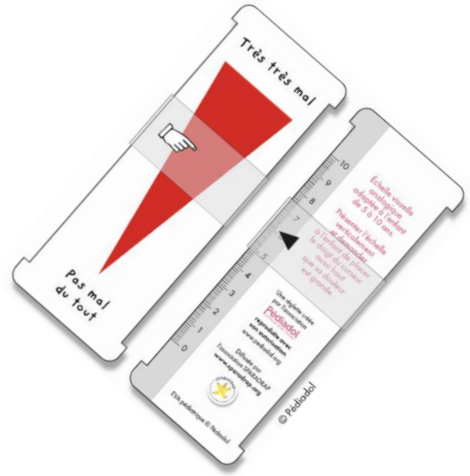




*Newsletter n° 4 - Prise en charge de la douleur*

## TAKE HOME MESSAGES

### Douleur = ÉVALUER + TRACER.

→ Dès l’arrivée, j’utilise **une échelle adaptée au patient** et je trace le résultat dans le dossier.




### Un antalgique administré = une douleur RÉÉVALUÉE.

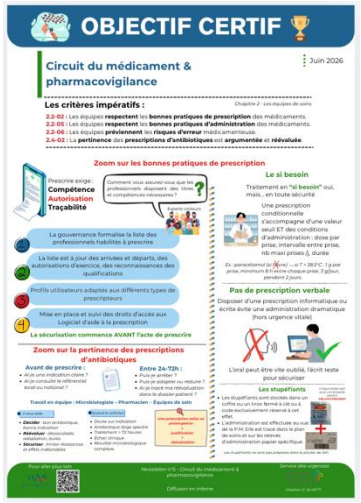
→ Aux urgences : réévaluation **45 min à 2 h après l’antalgique** et traçabilité dans le dossier.




### La douleur, ça s’ANTICIPE aussi !

→ Avant un soin ou un geste douloureux, je prévois les moyens adaptés : **médicamenteux et/ou non médicamenteux.**

# OBJECTIF CERTIF’







*Newsletter n°5 - Circuit du médicament & pharmacovigilance*

## TAKE HOME MESSAGES

**Pas de prescription verbale, hors urgence vitale.**

→ **Ce qui est prescrit est écrit, ce qui est administré est tracé.**

**Bien sortir, c’est être bien informé !**

→ La lettre de liaison à la sortie, avec un **volet médicamenteux**, le traitement à poursuivre (avec posologie, forme galénique, durée) et traitements arrêtés

**De la préparation à l’administration : MÊME SOIGNANT, sans interruption !**

→ Une administration ou une non-administration est **tracée au plus près de la prise.**

# OBJECTIF CERTIF’




*Newsletter n° 6 - Urgences vitales*

## TAKE HOME MESSAGES

### Urgence vitale ? J’ALERTE : 73 33 !

→ Je connais le **numéro d’appel de la réanimation** et la localisation du matériel d’urgence.

### ACR = ALERTER + MASSER + DELIVRER LE CHOC (si nécessaire) sans délai.

→ La prise en charge repose sur la **rapidité, la coordination de l’équipe et l’accès immédiat au matériel**.

### Je sais où est mon chariot d’urgence et comment l’utiliser.

→ Je connais son organisation et je m’appuie sur le **Médi-Mémo SAUV** pour sécuriser les préparations et limiter le risque d’erreur.

# OBJECTIF CERTIF'







*Newsletter n°7 - Hygiène - Prévention du risque infectieux*

## TAKE HOME MESSAGES

### ZÉRO bijou, ZÉRO vernis, ongles courts, manches courtes !

→ Les prérequis à l'hygiène des mains, **c'est tout le temps et pour tous.**

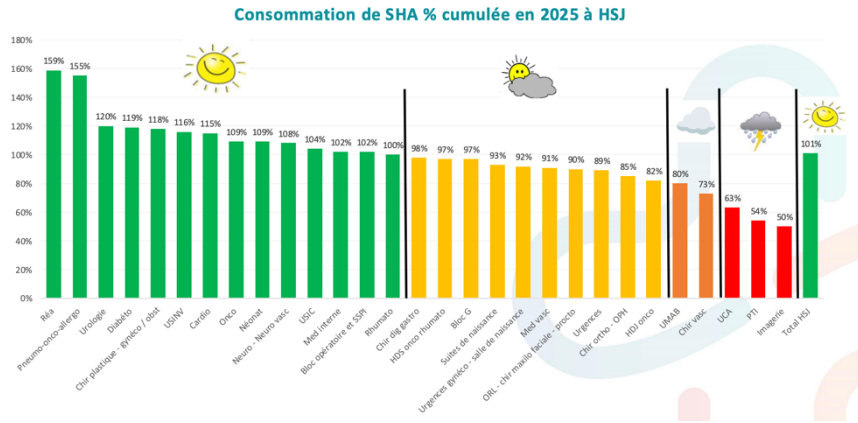
### Hygiène des mains : la SHA est mon premier réflexe !

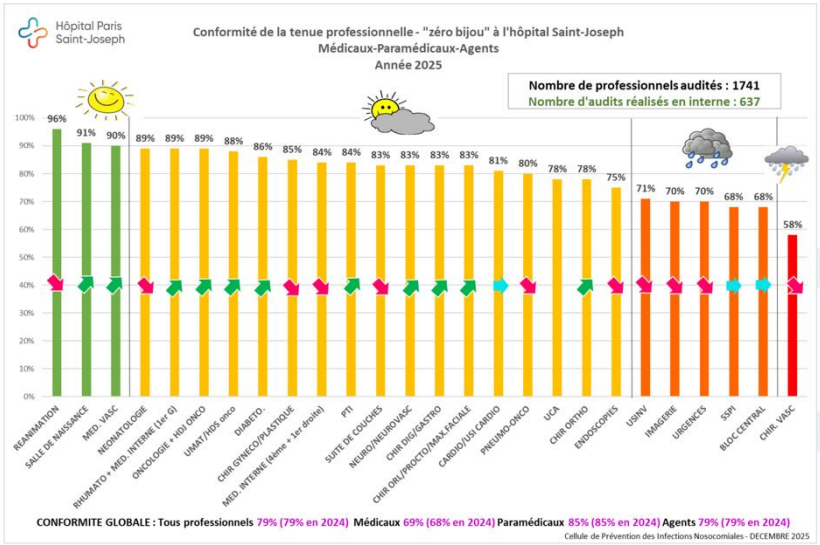
→ **Friction hydroalcoolique en priorité** ; eau + savon si mains visiblement sales/souillées ou après les toilettes.

### Précautions STANDARD = pour TOUS les patients !

→ Quel que soit leur statut infectieux. Les précautions complémentaires **s'ajoutent** aux précautions standard, elles ne les remplacent pas.

**Consommation de Solution Hydro-Alcoolique (SHA) 2025 (du 01/01/2025 au 31/12/2025)**




*G. SILVETTI - IDE Référent, service des urgences.*

# OBJECTIF CERTIF’

## TAKE HOME MESSAGES

**La bientraitance, c’est aussi dans les “petites choses”.**

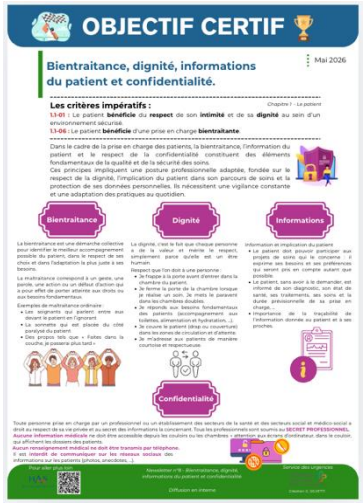
**→ Je parle AU patient, pas DU patient devant lui.**
Je respecte ses choix, ses besoins et je l’implique dans sa prise en charge.

**Même aux urgences, je préserve l’intimité et la dignité.**

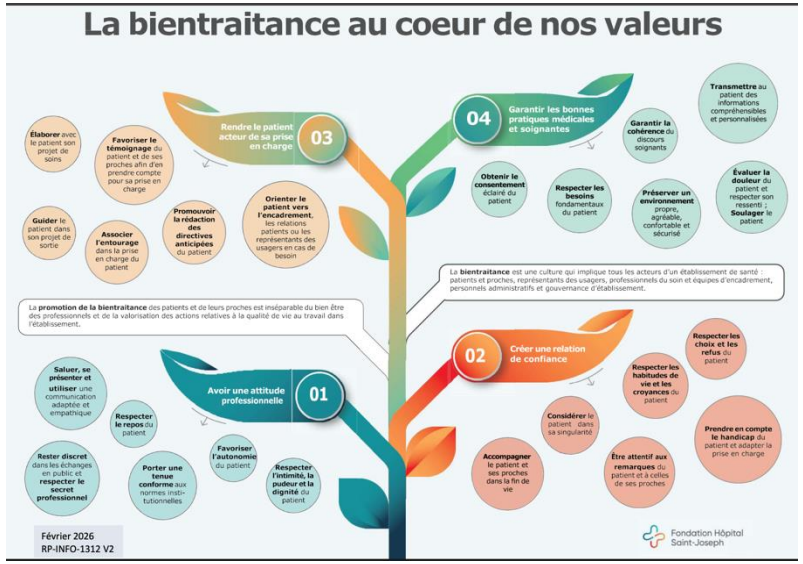
**→ Porte fermée • paravent • patient couvert • besoins fondamentaux respectés.**

**Confidentialité : ce qui concerne le patient reste confidentiel.**

**→ Attention à ce que l’on dit, à ce que l’on voit sur les écrans et à ce que l’on partage.**




*Newsletter n°8 - Bientraitance, dignité, informations du patient et confidentialité.*



# OBJECTIF CERTIF’




*Newsletter n°9 - Sécurité transfusionnelle et Etraceline*

## TAKE HOME MESSAGES

### TRANSFUSION = IDENTITOVIGILANCE à CHAQUE ÉTAPE !

→ Du prélèvement jusqu’à la fin de la transfusion : **je contrôle l’identité et la concordance.**
**Erreur d’identité = risque d’accident transfusionnel ABO.**

### 1 CGR = 1 IDE = 30 MIN

→ Une transfusion d’un CGR nécessite **une IDE** pendant **30 min**, préparation, vérification, test ultime au lit du patient et surveillance **15 min.**

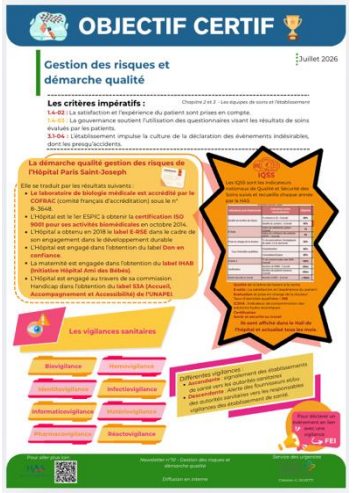
### Transfusion aux urgences si instable hémodynamiquement ou urgence vitale.

→ Si le patient est **stable**, la transfusion peut se faire en hospitalisation (service).

*G. SILVETTI - IDE Référent, service des urgences.*

# OBJECTIF CERTIF’




*Newsletter n°10 - Gestion des risques et démarche qualité*

## TAKE HOME MESSAGES

### Un événement indésirable ou un “presqu’accident” ? Je le DÉCLARE !

→ **Tous les professionnels peuvent déclarer, même si le patient n’a subi aucune conséquence.**

### Déclarer, ce n’est pas chercher un coupable : c’est éviter que cela se reproduise.

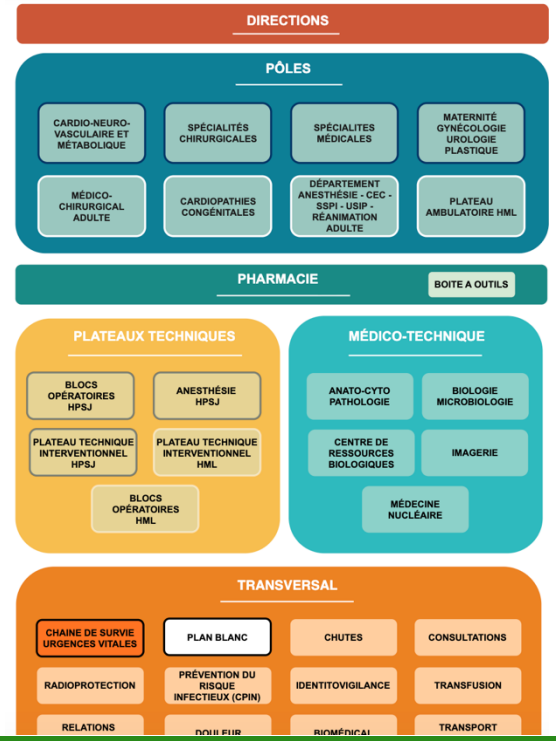
→ Les événements sont analysés collectivement (**CREX / RMM**) pour identifier les causes et **améliorer nos pratiques**.

### Un doute sur la conduite à tenir ? → BlueKanGo !

→ **Protocole** = “Que dois-je faire ?”
→ **Procédure** = “Comment le faire ?”

BlueKanGo



# OBJECTIF CERTIF’







*Newsletter n° 11 - Prévention du risque numérique (réseaux sociaux)*

## TAKE HOME MESSAGES



### Réseaux sociaux : SECRET PROFESSIONNEL, toujours !

→ **Aucune photo, anecdote ou information permettant d’identifier un patient.**
Changer le nom du patient ne garantit pas son anonymat.

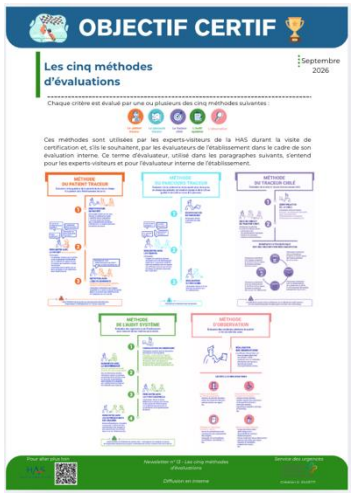
### Un mail douteux ? Je ne clique PAS !

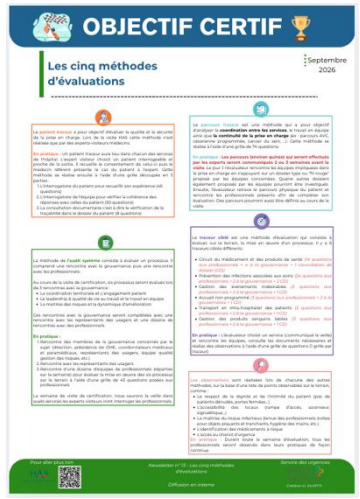
→ Je le transfère à securite.informatique@ghpsj.fr.

### Suspicion de cyberattaque = 3 réflexes :

→ **1. Je débranche le PC du RÉSEAU, pas du secteur**
→ **2. J’alerte : 11 / 3300 / cadre de garde**
→ **3. Je préviens mes collègues et mon cadre**

# OBJECTIF CERTIF’




*Newsletter n° 13 - Les cinq méthodes d’évaluations*

## TAKE HOME MESSAGES

### La certification, ce n’est pas un oral : c’est notre QUOTIDIEN !

→ Les experts **questionnent, observent et consultent les dossiers** pour vérifier nos pratiques.

### Face à l’expert : j’explique simplement CE QUE JE FAIS et POURQUOI.

→ Pas besoin de réciter le référentiel : **je décris ma pratique réelle et je sais où retrouver nos procédures**.

### Nous sommes TOUS concernés, pendant TOUTE la visite.

→ Hygiène des mains, tenue, dignité, intimité, médicaments à risque, chariot d’urgence… **nos pratiques sont observées en continu.**

## AUX URGENCES

**0 patients traceurs**

**2 parcours traceurs :**

**Urgences – USIC – Cardio – SMR (12/10)**
**Urgences – Réa – Décès (14/10)**

**? Traceurs ciblés**

*(**Restriction des libertés***
*Prévention des AES*
*Circuit médicaments*
***Transfusion**)*

**? Audits systèmes**

*(Rencontre avec les professionnels*
*Risque numérique rencontre avec les professionnels)*

***Les traceurs ciblés et les audits systèmes sont décidés la semaine de la certification, voir le jour même.***

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

*G. SILVETTI - IDE Référent, service des urgences.*

# MERCI POUR VOTRE ECOUTE

## PODIUM DES CHALLENGE OBJECTIF CERTIF’

